★★★围术期（0~3题）

术前（2007、2008、2009、2016、2020、2021、2023）

- 最短禁食时间：清饮料 2h、母乳 4h、牛奶 6h、淀粉类固体食物 6h、脂肪等肉类 8h“清母牛肉粉 24686”
- 高血压继续服用降压药避免戒断综合征，BP ≤ 140/90
- NSAIDs 术前 2~3 天（阿司匹林术前 7 天）、氯吡格雷术前 10 天停用，血小板＜ 50 需输血小板“san、七匹狼、石雷鹏、武术”
- 仅以饮食控制糖尿病：不必特殊准备
  平时口服降糖药：继续服至术前 1 天（长效降糖药在术前 2~3 天停服）
  平时用胰岛素：在手术日晨停用“3 长 1 短素当天”
  维持血糖在 5.6~11.2 的轻度升高状态

术后

体位

- 全麻未清醒：平卧、头转向一侧
  腰麻：去枕平卧 / 头低卧位
- 全麻清醒后
  腰麻 6 小时后
  - ①颅脑手术：头高脚低斜坡卧位
  - ②颈、胸手术（食管癌等）：高半坐位
  - ③腹部手术（胃大部切除术等）：低半坐位
  - ④腹腔内有污染：半坐 / 卧或头高脚低位
  - ⑤休克：头和躯干抬高 20°~30°、下肢抬高 15°~20°

拆线

- 头面颈 4~5d、下腹 / 会阴 6~7d、躯干其他部位 7~9d、四肢 10~12d、减张缝合 14d
  “双 11 剁手、心痛吧、我头痛死、起来遛下会阴、剪了要死”

并发症（2011、2026）

- 发热（最常见）
  - 术后 1.4 天吸收热、输血输液等；术后 2.7 天感染可能大
- 低体温
- 肺膨胀不全、感染、肺栓塞
- 尿潴留
  - 协助患者自行排尿→导尿→导尿量＞ 500ml 留置尿管 1~2 天
- 胃、结肠蠕动显著减弱

切口

- 分类（2012）
  - Ⅰ清洁切口：甲状腺手术
  - Ⅱ可能污染切口：胃手术、皮肤不易彻底消毒处、6 小时内伤口清创术缝合、新缝合切口再度切开
  - Ⅲ污染切口：阑尾化脓穿孔行切除术、绞窄坏死肠管切除术
- 愈合
  “三甲医院就是要让Ⅲ类切口甲级愈合”
  - 甲级：优良
  - 乙级：有炎症、没化脓
  - 丙级：化脓、需引流
- 并发症
  - 切口积血（最常见）
  - 切口血清肿：术中切断较多淋巴管（乳房、腹股沟区手术）
  - 切口感染：红肿、脓液流出（2026）
  - 切口裂开：多在咳嗽、腹胀后流出淡红色液体（2023、2025）